

# Sub-registro de nascimento e prioridades territoriais no Brasil

## Evidências de 2022 a 2024 e uma proposta de monitoramento

Osmarsrjunior · Registro em Foco · Setembro de 2026

Estudo independente de pesquisa aplicada. Versão 1.0. Sem vínculo institucional com IBGE, MDHC ou PNUD. Preparado com assistência de inteligência artificial na programação e redação. Não submetido a avaliação por pares.

### Resumo

Este estudo investiga como estimativas territoriais de sub-registro de nascimento podem informar o planejamento de políticas públicas. Foram analisadas as tabelas agregadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 2022, 2023 e 2024, preservando os arquivos revisados disponíveis em setembro de 2026. A taxa nacional passou de 1,3111% para 0,9548%, uma redução de 0,3563 ponto percentual ou 27,18% em termos relativos. Em 2024, Roraima apresentou a maior taxa estadual, de 13,8634%, enquanto o Pará concentrou o maior volume aproximado de eventos sub-registrados, calculado a partir das taxas e dos totais publicados. A distinção entre intensidade relativa e volume sugere critérios complementares de investigação territorial. Propõe-se um arranjo de monitoramento que combina resultados populacionais, qualidade dos dados, acesso aos serviços e responsabilidades institucionais. A análise é descritiva: não estima efeitos causais das políticas, não identifica indivíduos e não mede o estoque de pessoas sem documentação. O trabalho oferece código reproduzível, painel exploratório e instrumentos técnicos para discussão.

Palavras-chave: registro civil; sub-registro de nascimento; desigualdade territorial; indicadores; políticas públicas.

### 1 Introdução

O registro civil de nascimento conecta a existência jurídica da pessoa a uma rede de serviços e documentos. A formulação de políticas nessa área exige distinguir a ocorrência do nascimento, seu registro e a obtenção posterior de documentos. Uma melhora no registro de nascimentos recentes não informa, por si só, quantas pessoas de diferentes idades continuam enfrentando barreiras documentais.

O Edital nº 04/2026 do projeto BRA/23/024 estabelece uma demanda de apoio técnico à formulação do Segundo Plano da Política Nacional de Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica. Seus produtos abrangem diagnóstico, diretrizes, metas, indicadores, governança, participação e subsídios normativos [1]. O presente estudo utiliza essa demanda como referência temática para um exercício independente de pesquisa aplicada.

O Acórdão nº 2758/2025 do TCU, Plenário, recomenda ao MDHC considerar metas e resultados, indicadores relevantes, avaliação periódica e definição dos papéis dos atores. Também recomenda indicadores sobre demandas, tempos de atendimento e sucesso dos pedidos de registro tardio e segunda via [2, itens 9.2.1 e 9.3.4]. Essas duas dimensões orientam o argumento: acompanhar a cobertura do registro e acompanhar a experiência de acesso aos serviços.

A pergunta de pesquisa é: como as diferenças territoriais nas estimativas de sub-registro podem orientar prioridades e instrumentos de monitoramento? O objetivo consiste em descrever a trajetória recente, comparar critérios de seleção de territórios e traduzir os achados em uma proposta verificável de acompanhamento. Não se pretende formular a versão oficial de um plano nacional nem substituir pactuação federativa e participação social.

## **2 Dados e método**

### **2.1 Fontes e recorte**

A fonte quantitativa é a coleção Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos do IBGE. O núcleo analítico utiliza a Tabela 1.1 de cada ano, com total estimado de nascidos vivos, percentual de sub-registro do IBGE e percentual de subnotificação do Ministério da Saúde, segundo a residência da mãe [3–5]. Foram preservados o Brasil, as cinco grandes regiões, as 27 unidades da Federação e a categoria de residência ignorada.

Os arquivos de 2022 e 2023 incorporam a revisão identificada no nome dos arquivos como 20260610. A edição de 2024 foi obtida no mesmo dia de consulta, 11 de setembro de 2026. Assim, a comparação utiliza as versões disponíveis nessa data, e não números de releases antigos. Novas revisões podem alterar os resultados. Os endereços, datas e hashes SHA-256 estão registrados em `data/sources.json`.

A Tabela 1.2 de 2024 foi extraída como base municipal complementar. Ela contém 5.570 linhas com códigos municipais. Três registros apresentam marcadores de ausência para as medidas analisadas: Nantes, Peritiba e Anhanguera. Esses valores foram mantidos vazios, sem substituição por zero. As Tabelas 1.3 e 1.4 sustentam uma análise complementar por idade da mãe e local do nascimento. Essas classificações não foram cruzadas com a base estadual para evitar fabricar relações que não estão presentes nas tabelas utilizadas.

### **2.2 Medidas e cálculos**

As taxas publicadas são utilizadas diretamente em unidades percentuais. O cálculo do volume aproximado de eventos sub-registrados segue  $V = N \times p / 100$ , em que  $N$  é o total estimado de nascimentos e  $p$  é o percentual publicado.  $V$  é uma medida derivada, sujeita aos arredondamentos de ambos os insumos. Não corresponde a uma contagem observada de indivíduos localizáveis.

A variação em pontos percentuais corresponde à taxa de 2024 menos a taxa de 2022. A variação relativa corresponde a  $100 \times (\text{taxa de 2024} / \text{taxa de 2022} - 1)$ . O projeto preserva a precisão original nos dados e apresenta arredondamentos na comunicação. O agregado nacional é o publicado pelo IBGE; não é calculado pela média simples das taxas estaduais.

Foram comparadas duas ordenações estaduais: a taxa de sub-registro e o volume aproximado. A primeira informa a intensidade relativa do problema na população de nascimentos estimados. A segunda aproxima sua escala absoluta. Não foi criado um índice composto, pois a escolha de pesos envolveria valores e prioridades não definidos por esta pesquisa.

### 2.3 Procedimentos de qualidade

O processamento automatizado lê os arquivos XLSX dentro dos ZIPs originais, separa linhas de dados e notas e utiliza códigos para identificar estados. As verificações incluem integridade dos arquivos, unicidade das chaves, presença das 27 unidades em cada ano, limites de taxas e reconciliação entre totais estaduais, residência ignorada e Brasil. As pequenas diferenças de centésimos nos totais são compatíveis com a precisão publicada.

O projeto reutiliza as estimativas produzidas pelo IBGE, cuja abordagem envolve o pareamento de registros e informações de saúde [6]. Não reproduz o pareamento de microdados nem reestima o modelo estatístico. As tabelas selecionadas não fornecem intervalos de incerteza para todos os valores utilizados; portanto, diferenças de posição não são tratadas como diferenças estatisticamente significativas. A série de três anos sustenta uma descrição recente, insuficiente para extrapolação automática de tendências.

## 3 Resultados

### 3.1 Redução nacional no período

A taxa nacional foi de 1,3111% em 2022, 1,0496% em 2023 e 0,9548% em 2024. O movimento representa redução de 0,3563 ponto percentual entre os extremos, equivalente a 27,18% da taxa inicial. Aplicando as taxas aos totais estimados, o volume aproximado passa de 33.755 para 22.902 eventos anuais. Essa diferença combina mudanças na taxa e no número de nascimentos estimados, que caiu de aproximadamente 2,575 milhões para 2,399 milhões.

| Ano  | Nascimentos estimados | Sub-registro (%) | Volume aproximado |
|------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 2022 | 2.574.556             | 1,3111           | 33.755            |
| 2023 | 2.548.631             | 1,0496           | 26.750            |
| 2024 | 2.398.634             | 0,9548           | 22.902            |

Fonte: IBGE, Tabela 1.1 de 2022, 2023 e 2024. Volume calculado pelo projeto. Valores de nascimentos e volumes arredondados para apresentação.

A trajetória nacional não permite atribuir a redução a uma ação específica. Não há grupo de comparação, identificação de exposição às intervenções ou controle de fatores concorrentes neste desenho. Sua utilidade é estabelecer uma referência temporal e revelar a necessidade de examinar os componentes territoriais do agregado.

### 3.2 Diferenças regionais e estaduais

Em 2024, a taxa foi de 3,5280% no Norte, 1,3358% no Nordeste, 0,5801% no Centro-Oeste, 0,2646% no Sudeste e 0,2544% no Sul. Doze unidades da Federação ficaram acima do percentual nacional. Esses números descrevem heterogeneidade territorial, sem explicar isoladamente seus determinantes.

#### Sub-registro por grande região em 2024

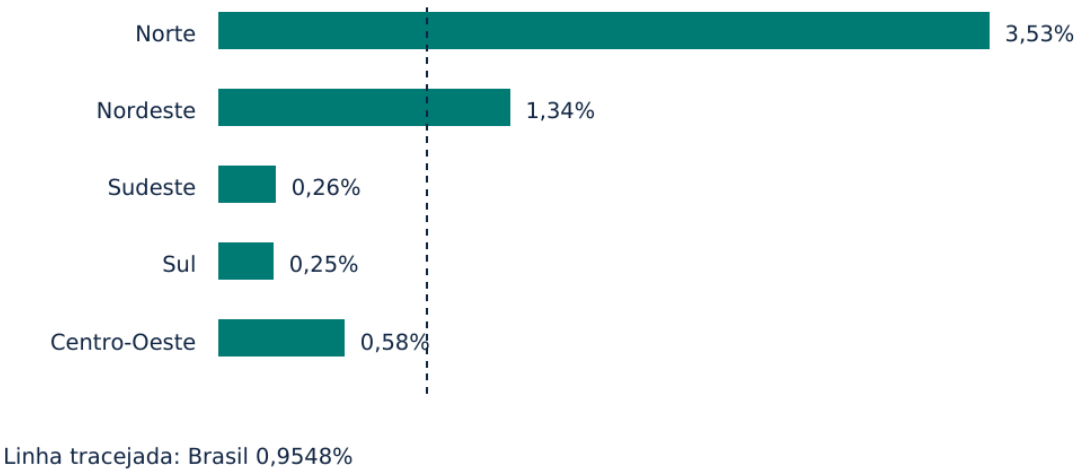


Figura 1. Taxa de sub-registro por grande região em 2024. Fonte: IBGE, Tabela 1.1. A linha de referência corresponde ao Brasil, 0,9548%.

As cinco maiores taxas estaduais foram observadas em Roraima, Amapá, Amazonas, Piauí e Sergipe. A taxa de Roraima, 13,8634%, deve motivar investigação contextual sobre atendimento e cobertura das bases. A tabela agregada não permite atribuir esse resultado a migração, distância, pertencimento étnico ou qualquer outro mecanismo específico.

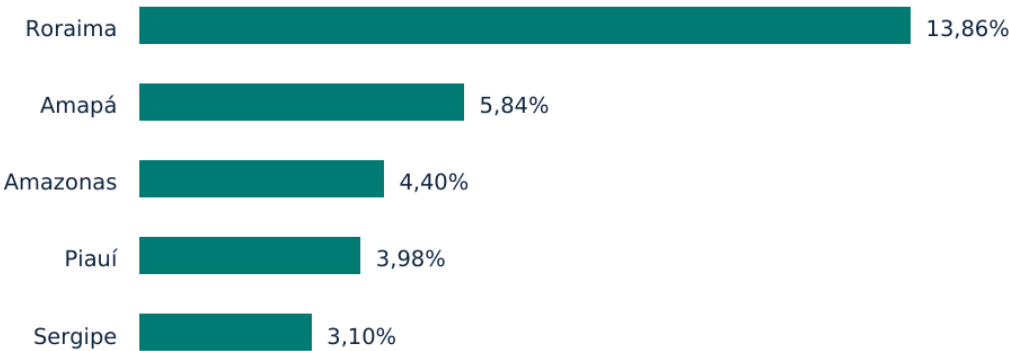
| Estado   | Taxa em 2024 (%) | Volume aproximado |
|----------|------------------|-------------------|
| Roraima  | 13,8634          | 1.724             |
| Amapá    | 5,8405           | 731               |
| Amazonas | 4,3987           | 2.916             |
| Piauí    | 3,9814           | 1.584             |
| Sergipe  | 3,0981           | 853               |

Fonte: IBGE, Tabela 1.1 de 2024. Seleção pelas cinco maiores taxas, não pelos volumes.

### 3.3 Taxa e volume produzem prioridades distintas

Quando a ordenação considera o volume aproximado, aparecem Pará, Amazonas, Maranhão, Roraima e Piauí. Esses estados correspondem a aproximadamente 49,60% do volume nacional derivado. O Pará apresenta taxa de 2,8067%, inferior à de Roraima, mas cerca de 3.331 eventos estimados, diante de aproximadamente 1.724 em Roraima. A maior população de nascimentos estimados altera a escala do problema.

#### Cinco maiores taxas estaduais



#### Cinco maiores volumes aproximados

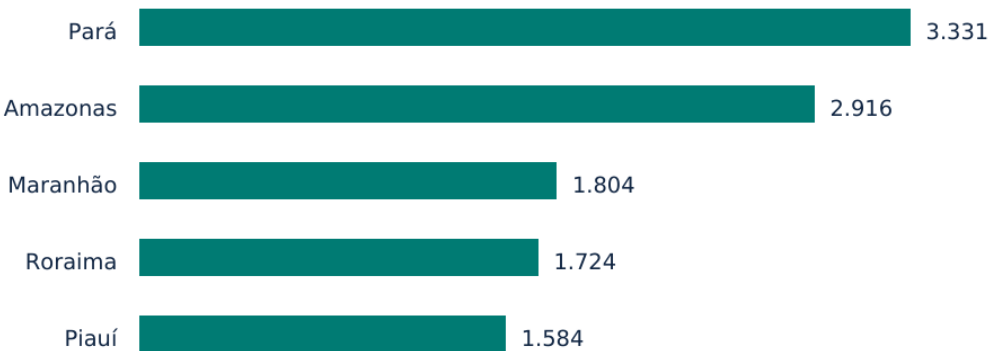


Figura 2. Ordenações estaduais por taxa e volume aproximado em 2024. Fonte: IBGE, Tabela 1.1, e cálculos do projeto. Cada painel apresenta sua própria unidade de medida.

Uma seleção baseada apenas no volume pode deixar de examinar territórios com elevadas taxas e menor população. Uma seleção exclusivamente proporcional pode reduzir a atenção a locais onde um percentual menor ainda representa muitos eventos. A proposta é usar duas listas complementares como ponto de partida para diagnóstico, explicitando o critério em vez de produzir uma classificação única de desempenho.

### 3.4 Recortes complementares

Na Tabela 1.3 de 2024, os nascimentos de mães com menos de 15 anos apresentam taxa de 6,09508%. Na Tabela 1.4, a taxa é de 0,8265% para nascimentos em hospital e de 9,2573% para nascimentos em domicílio. Os achados indicam grupos de observação relevantes para estudos posteriores, sem comprovar o efeito da idade ou do local do parto sobre o registro.

Os denominadores e perfis desses grupos diferem. A comparação não autoriza atribuir o problema às mães, recomendar intervenções individuais ou presumir que uma mudança no local de nascimento produziria a diferença observada. O uso adequado consiste em orientar perguntas sobre fluxos de atendimento e barreiras, a serem investigadas com métodos e participação apropriados.

## 4 Da análise ao monitoramento

Propõe-se organizar o acompanhamento em três camadas. A primeira utiliza a taxa e o volume aproximado como medidas populacionais anuais. A segunda examina os processos de atendimento, com tempo até resolução, conclusão de encaminhamentos e motivos de pendência. A terceira acompanha a qualidade da informação, a atualização das fontes e o funcionamento dos mecanismos de governança.

Somente a primeira camada dispõe de valores calculados neste projeto. As demais são especificações para eventual coleta administrativa. Não se atribuem valores a indicadores operacionais sem registros de atendimento. Essa separação permite uma matriz utilizável sem apresentar suposições como resultados.

Para iniciar a investigação territorial, sugere-se discutir as cinco maiores taxas e os cinco maiores volumes, preservando os territórios comuns às duas listas e justificando quaisquer inclusões adicionais. O número cinco é uma convenção de exploração do portfólio, não um limiar oficial de elegibilidade. A escolha final deve incorporar recursos disponíveis, conhecimento local, cobertura informacional e participação dos grupos afetados.

O painel contém uma simulação baseada em redução relativa constante da taxa. Para uma redução anual  $r$ , o valor no horizonte  $n$  corresponde a  $p$  inicial  $\times (1 - r)$  elevado a  $n$ . A ferramenta serve para visualizar a escala de uma ambição de redução. Seus resultados não são previsão, meta pactuada ou avaliação de custo. Um cenário que parte de 2022 inclui anos já observados; nesse caso, deve ser lido como exercício contrafactual ilustrativo, nunca como projeção atual.

As metas operacionais precisam ser negociadas com os atores responsáveis. A matriz complementar propõe campos para linha de base, denominador, fonte, frequência, responsável sugerido, risco e revisão. Um responsável sugerido não constitui atribuição legal. A implementação dependeria de arranjos formalmente definidos e de validação das competências de cada instituição.

## 5 Limitações e agenda de pesquisa

O estudo utiliza agregados, o que impede identificar indivíduos, avaliar trajetórias documentais e inferir relações individuais a partir de diferenças territoriais. O indicador de sub-registro de nascimentos recentes não mede o estoque de pessoas sem certidão nem as dificuldades de acesso a segunda via, CPF ou outros documentos. Uma avaliação da documentação básica demanda indicadores próprios.

Revisões estatísticas podem alterar níveis e comparações. O projeto registra a versão das fontes, mas não resolve limitações do modelo do produtor. Arredondamentos afetam volumes derivados e somas. Percentuais municipais associados a poucos nascimentos podem variar intensamente e exigem cuidado adicional. A ausência de três valores municipais foi preservada e identificada.

A janela 2022–2024 é curta. O desenho não demonstra que a redução será mantida, não separa mudanças reais de eventuais efeitos informacionais e não mede impacto de unidades interligadas, mutirões ou estratégias itinerantes. Um estudo causal exigiria dados sobre implantação, intensidade, seleção e exposição às ações, além de um desenho de comparação defensável.

Também não houve entrevistas, consulta pública ou validação com gestores e usuários. O dossiê contém um protocolo para essa etapa e exemplos claramente simulados de sistematização. Uma continuidade possível seria selecionar estudos de caso após a análise quantitativa, reconstruir fluxos locais de atendimento e discutir barreiras com participantes, respeitando as condições éticas e institucionais aplicáveis.

## 6 Conclusão

A queda nacional entre 2022 e 2024 convive com diferenças expressivas nas taxas estaduais. Taxas e volumes produzem ordenações distintas, de modo que a seleção de territórios precisa declarar qual pergunta pretende responder. O monitoramento proposto combina resultados populacionais e indicadores operacionais a construir, sem confundir disponibilidade de dados com cobertura integral da política.

A contribuição prática é uma cadeia verificável entre fonte, cálculo, visualização e proposta de ação. O painel torna as medidas exploráveis; o artigo explicita a interpretação; o dossiê apresenta instrumentos para planejamento e debate. A passagem desses instrumentos para uma política efetiva requer pactuação, recursos, participação e avaliação, etapas que este exercício não substitui.

## Referências

[1] MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. Edital nº 04/2026, Projeto BRA/23/024. Segundo Plano da Política Nacional de RCN. 2026. Itens 8 a 11. [https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/cooperacao-internacional/editais/editais-2026/BRA.23024\\_Edital\\_04.2026\\_SNDH.pdf/@download/file](https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/cooperacao-internacional/editais/editais-2026/BRA.23024_Edital_04.2026_SNDH.pdf/@download/file)

[2] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2758/2025, Plenário. Processo TC 003.493/2025-3. BTCU, ano 8, nº 226, 5 dez. 2025. Itens 9.2.1, 9.2.3 e 9.3.4. <https://btku.apps.tcu.gov.br/api/obterDocumentoPdf/79402061>

[3] IBGE. Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos 2022. Tabela 1.1. Arquivo revisado em 10 jun. 2026. [https://ftp.ibge.gov.br/Estatisticas\\_Vitais/Estimativas\\_sub\\_registro\\_nascimentos/2022/xlsx/01nascidosvivos\\_xlsx\\_20260610.zip](https://ftp.ibge.gov.br/Estatisticas_Vitais/Estimativas_sub_registro_nascimentos/2022/xlsx/01nascidosvivos_xlsx_20260610.zip)

[4] IBGE. Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos 2023. Tabela 1.1. Arquivo revisado em 10 jun. 2026. [https://ftp.ibge.gov.br/Estatisticas\\_Vitais/Estimativas\\_sub\\_registro\\_nascimentos/2023/xlsx/01nascidosvivos\\_xlsx\\_20260610.zip](https://ftp.ibge.gov.br/Estatisticas_Vitais/Estimativas_sub_registro_nascimentos/2023/xlsx/01nascidosvivos_xlsx_20260610.zip)

[5] IBGE. Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos 2024. Tabelas 1.1 a 1.4. [https://ftp.ibge.gov.br/Estatisticas\\_Vitais/Estimativas\\_sub\\_registro\\_nascimentos/2024/xlsx/01nascidosvivos\\_xlsx.zip](https://ftp.ibge.gov.br/Estatisticas_Vitais/Estimativas_sub_registro_nascimentos/2024/xlsx/01nascidosvivos_xlsx.zip)

[6] IBGE. Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos. Apresentação da pesquisa e metodologia. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>

Fontes consultadas em 11 set. 2026. Os dados processados e os scripts integram o repositório <https://github.com/Osmarsrjunior/registro-em-foco>.